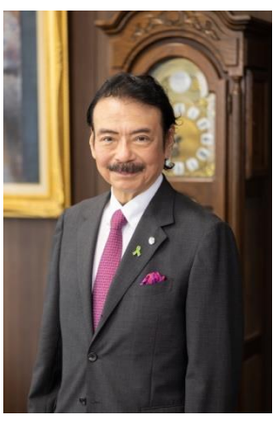
特　別　講　演

時間の変更がございます。ご注意ください。

2026年10月31日（土）13:50～14:50　第１会場（1F メインホール）



社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 理事長

松波　英寿　先生

座長：　森本　剛史

松波総合病院

学　　歴：

昭和	50年	3月	岐阜県立岐阜高校卒業
	56年	3月	東京医科大学医学部卒業
		5月	医師国家試験合格 第258903号
平成	8年	5月	信州大学医学部博士号授与

所属学会：

1. The Transplantation Society
2. The Transplantation Society of Australia and New Zealand
3. The International Society for Artificial Organs
4. 日本外科学会（専門医、指導医）
5. 日本臨床外科学会（特別会員）
6. 日本消化器外科学会（認定医）
7. 日本移植学会（移植認定医）
8. 日本消化器病学会
9. 日本肝臓学会
10. 日本肝移植学会（特別会員）
11. 日本臓器保存生物医学会（評議員）
12. 日本外科系連合学会
13. 日本癌治療学会
14. 日本内視鏡外科学会
15. 日本ロボット外科学会
16. 東海外科学会
17. 日本肝癌研究会
18. 日本輸血細胞治療学会（細胞治療認定管理師）
19. 日本内視鏡下肥満・糖尿病外科研究会
20. 日本肥満学会
21. セルロース学会
22. 日本公衆衛生学会
23. 日本臨床検査医学会
24. 日本肥満症治療学会
25. 日本遠隔医療学会

職　　歴：

昭和	56年	5月	岐阜大学医学部第一外科 研修医	
	57年	1月	国立東静病院 研修医	
	58年	5月	同 レジデント	
	59年	1月	岐阜赤十字病院外科 医師	
	60年	4月	岐阜大学医学部第一外科 医員	
	64年	1月	岐阜大学医学部第一外科 助手（文部教官）	
		3月	ﾌﾞﾘﾝｾｽ ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾗ病院（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾌﾞﾘｽﾍﾞﾝ） 研究員	
平成	2年	3月	同 上級研究員	
		6月	信州大学医学部第一外科 助手（文部教官）	
	3年	6月	名古屋市立大学医学部 非常勤講師	
	7年	4月	横浜市立大学医学部 非常勤講師	
	8年	5月	信州大学医学部第一外科 講師（文部教官）	
			松波総合病院 副院長	
			信州大学医学部第一外科 委嘱講師	現在に至る
	12年	12月	東京大学医学部外科学　客員教授	
	13年	7月	医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 理事長	
	15年	3月	南開大学外科学 客員教授・名誉教授（中国 天津）	
		5月	日本病院会 社員（代議員）	
	16年	3月	ﾘﾘｰ病院外科 客員教授（ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ｶﾘｰ）	
		5月	ﾌﾚﾆｰ病院外科・臓器移植科 客員教授（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ）	
	20年	10月	社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 理事長	現在に至る
	22年	6月	岐阜大学腫瘍外科学 非常勤講師	
		10月	京都大学医学部人間健康科学科 非常勤講師	
	23年	4月	岐阜大学腫瘍外科学 客員臨床系医学教授	現在に至る
			大垣市医師会看護専門学校 非常勤講師	現在に至る
	24年	5月	羽島郡医師会 会長	現在に至る
			岐阜県医師信用組合 理事	現在に至る
	24年	6月	岐阜県病院協会 理事	
	26年	12月	朝日大学 客員教授→29年4月 朝日大学歯学部客員教授	現在に至る
	27年	4月	岐阜聖徳学園大学看護学部 客員教授	
	31年	3月	全日本病院協会 理事	現在に至る
令和	元年	7月	岐阜県病院協会 副会長	
	2年	6月	岐阜県医師会 監事	現在に至る
	4年	6月	岐阜県病院協会 会長	現在に至る
	5年	5月	日本病院会 理事	
	5年	6月	岐阜県老人保健施設協会 副会長	
	6年	4月	日本医療法人協会 岐阜支部長	現在に至る
	7年	5月	日本病院会 常任理事	現在に至る
	7年	12月	学校法人神野学園 岐阜医療科学大学 客員教授	現在に至る
	8年	4月	岐阜県老人保健施設協会 会長	現在に至る

ご存じですか？　今、日本の医療が大きく変わろうとしています。
― 新たな地域医療構想を理解しましょう ―

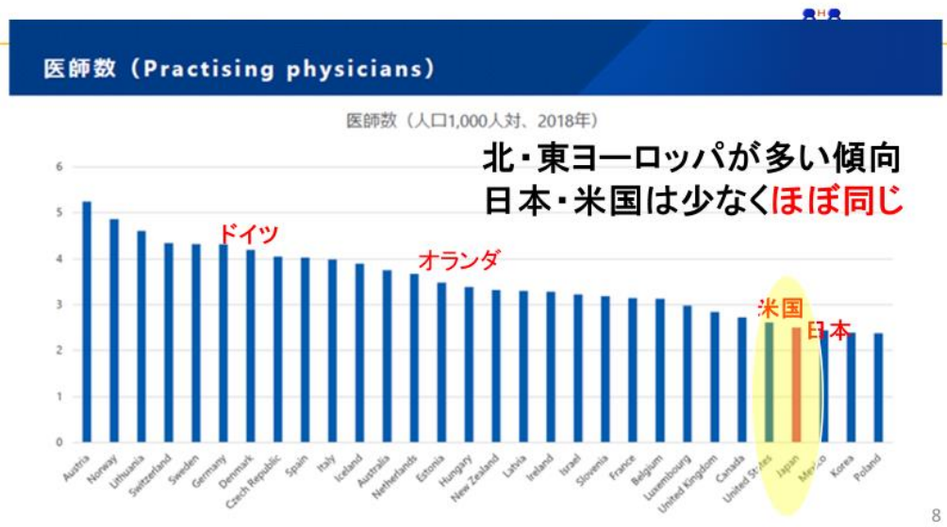
本邦の医療制度は、戦後の経済成長とともにめざましい発展を遂げ、現在に至っています。日本の医療制度の特徴を一言で言えば、「国民皆保険のもと、患者は比較的自由に医療機関を受診でき、民間・公立・公的医療機関が混在して医療を提供する一方、診療報酬という公定価格によって国が強くコントロールしている制度」といえるでしょう。その結果、乳児死亡率や平均寿命などの指標において、日本は世界最高水準を達成してきました。一方で、「日本の標準的な医療水準は米国と比較しても高い」と言われても、違和感を覚える方は少なくないでしょう。まして、私たち医療従事者の労働環境が世界最高水準にあると感じている人は、ほとんどいないのではないでしょう。なぜなのでしょうか。

米国は日本より人口がはるかに多く、医師・看護師数も多いものの、人口当たりでみれば医療従事者数に極端な差があるわけではありません（図―１）。それにもかかわらず、日本の医療現場では、人員不足や過重労働が強く意識されています。その大きな理由の一つが、**医療機関や病床が多く、限られた医療資源、特に人的資源が多数の施設に分散している**ことにあります。その結果、一つひとつの医療機関に十分なスタッフを配置することが難しく、医療提供の効率が低下し、医療従事者の負担増加につながっています。

戦後、日本では病院・病床が増え続けました。しかし1980年ころから、このまま無秩序に病床が増加すれば、効率的な医療提供体制を維持することが困難になると予想され、1985年の医療法改正を経て医療計画制度が導入されました。都道府県が医療圏ごとに必要病床数を考える仕組みが整備され、民間の新たな病床の設置は抑制されるようになりましたが（図―２）、病床の機能分化や再編は十分には進まず、国は医療法改正を繰り返しながら、地域に必要な病床数と医療機能を適正化する政策を進めてきました。2014年から進められてきた地域医療構想も、その延長線上にあります。



図―１



図―２

従来の地域医療構想では、2025年を見据え、地域の医療需要に応じた病床機能の適正化と、医療機関相互の役割分担・連携を進めることが目標とされました。しかし、その実現は容易ではなかったため、2019年には、厚生労働省が全国の４２４の公立・公的医療機関の病院名を公表し、再編・統合を含めた再検証を求めました。しかし、その直後に新型コロナウイルス感染症が蔓延し、医療提供体制の再編議論はいったん大きく後退することになりました。コロナ禍を経て、再び病床機能の見直しや医療機関の役割分担が議論されていますが、目的は達成できていません。そして現在、国は**2040年を見据えた「新たな地域医療構想」**を進めようとしています。団塊ジュニア世代が高齢期を迎える2040年には、医療・介護を必要とする高齢者が増加する一方、医療を支える現役世代は大幅に減少します。つまり、医療需要が変化・増大するにもかかわらず、それを支える人材は減少することになります。現在と同じ医療提供体制をそのまま維持することが困難になることは明らかです。

新たな地域医療構想では、病院・医療機関が担う機能を大きく次のように整理しています。

① **医育及び広域診療機能**　大学病院本院が担う機能で、医師の育成、高度・専門医療、広域的な診療機能を担います。岐阜県では岐阜大学医学部附属病院　です。

② **急性期拠点機能**　手術や救急医療など、多くの医療資源を必要とする急性期医療を集約して提供する機能です。構想区域の人口20万-30万に一か所もうけられます。

③ **高齢者救急・地域急性期機能**　増加する高齢者救急を受け入れ、地域で必要な急性期医療を提供するとともに、高度な手術等を必要とする患者については急性期拠点機能を担う医療機関に搬送するとされています。

④ **在宅医療等連携機能**　在宅医療の提供、在宅療養患者の急変時対応、介護施設等からの患者受け入れなど、地域の在宅・介護分野を支える機能です。

⑤ **専門等機能**　特定の診療科や疾患に特化した専門医療、回復期リハビリテーション、中長期の入院医療などを担う機能です。

これまで多くの病院は、これらの機能のうち複数を一つの施設内で担ってきました。一つの病院に高度急性期・急性期・回復期・慢性期の病床が併存していることも珍しくありません。しかし今後は、地域全体の医療需要と限られた医療資源を考えながら、「どの病院が、どの機能を中心的に担うのか」をこれまで以上に明確にしていくことが求められます。これは単なる病床削減の問題ではありません。医師、看護師、臨床検査技師をはじめとする**限られた医療人材を、どこに、どのように配置するのかという医療資源再編の問題**でもあります。

こうした方向性を後押しするように、2026年の診療報酬改定でも、一定の症例数や診療体制を備えた医療機関を評価する考え方がより鮮明になっています。また、がん医療についても、これまで国は「がん医療の均てん化」を強く掲げてきましたが、最近では**「がん医療の均てん化・集約化」**という考え方を明確に打ち出しています。これは大きな政策転換を象徴しています。すべての医療をすべての地域・病院で提供するのではなく、地域で提供すべき医療は「均てん化」し、高度な技術や一定の症例数を必要とする医療については「集約化」する。限られた医療資源の中で、医療の質と持続可能性を両立させようとしているのです。

では、このように医療提供体制が大きく変わろうとしている今、私たちはどうすればよいのでしょうか。病院の設置主体、経営者、医療部門の責任者、そして一人ひとりの医療従事者には、それぞれの立場があり、それぞれの主張があるでしょう。容易に一つの正解を見いだすことはできません。しかし、一つだけ忘れてはならないことがあります。それは、**医療の主体は患者であり、医療従事者・病院ではない。**という事です。人口減少、高齢化、働き手の減少という避けることのできない社会構造の変化によって医療改革が求められているのであれば、私たちが考えるべき出発点は、「地域の患者を守るために、私たち医療従事者は何をすべきか」であるはずです。

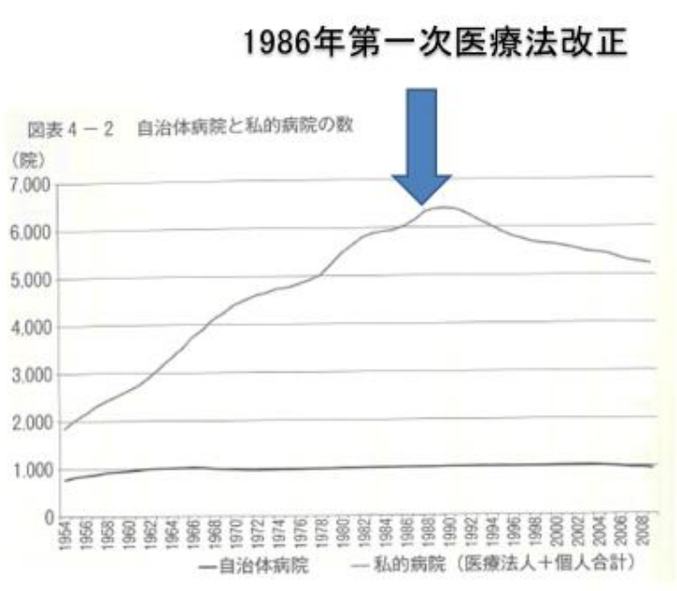
「自分の定年までは何も変わってほしくない」
「再編されたら通勤が不便になるから反対だ」
「自分の病院さえ残ればよい」
そのような個々の都合だけを優先していては、2040年の医療を守ることはできません。

病院が変われば、そこで働く臨床検査技師の役割も変わります。急性期医療が集約されれば、検査の種類、件数、緊急性、必要とされる専門性も変化します。外来医療、入院医療が縮小して在宅医療が拡大すれば、臨床検査の提供方法そのものも変わるでしょう。だからこそ、**「臨床検査の力で未来を拓く」**という今回の学会テーマは、まさに今の医療改革の本質を表していると思います。

さあ、あなたの病院はどうなりますか？
そして、そのとき臨床検査技師として、あなたは何をしますか？

再掲

昭和30年代以後の　自治体病院と私的病院の推移





36

図―３



令和7年8月27日第3回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方（案）

区域	現在の人口規模の目安	急性期拠点機能	高齢者救急・地域急性期機能	在宅医療等連携機能	専門等機能
大都市型	100万人以上 ※東京などの人口の極めて多い地域においては、個別性が高く、地域偏在等の観点も踏まえつつ別途整理	・将来の手術等の医療需要を踏まえ、区域内に複数医療機関を確保 ・都道府県からの依頼等を踏まえ、地域の医療機関へ医師を派遣する ※人口20万人～30万人毎に１拠点を確保することを目安とする。	・高齢者救急の対応の他、~~骨折の手術など一~~頻度の多い一部の手術についても対応	・診療所による在宅医療の実施が多い場合、そうした診療所や訪看ステーション等の支援 ・高齢者施設等からの患者受入等の連携	・特定の診療科に特化した手術等を提供 ・有床診療所の担う地域に根ざした診療機能 ・集中的な回復期リハビリテーション ・高齢者等の中長期にわたる入院医療　等
地方都市型	50万人程度	・将来の手術等の医療需要を踏まえ、区域内に１～複数医療機関を確保 ・都道府県からの依頼等を踏まえ、地域の医療機関へ医師を派遣する ※人口20万人～30万人毎に１拠点を確保することを目安とする	・高齢者救急の対応 ・手術等が必要な症例については地域の医療資源に応じて、急性期拠点機能を有する医療機関へ搬送	・地域の在宅医療の提供状況に応じて、在宅医療・訪問看護の提供や後方支援を実施 ・高齢者施設等からの患者受入れ等の連携	
人口の少ない地域	～30万人 ※20万人未満の地域については、急性期拠点機能の確保が可能かどうか等について特に点検し、圏域を設定	・手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約化し区域内に１医療機関を確保する ・地域の医療資源に応じて、高齢者救急・地域急性期機能や在宅医療等連携機能をあわせて選択することも考えられる ※大学病院本院が区域内にある場合、大学が担う医療の内容等を踏まえた上で、必要に応じて大学病院本院と別に医療機関を確保しうる	・地域の医療資源の範囲内で高齢者救急の対応 ・手術等が必要な症例については急性期拠点機能を有する医療機関へ搬送	・診療所による在宅医療の実施が少ない場合、自ら在宅医療や訪問看護を提供 ・高齢者施設等からの患者受入れ等の連携	

※　地域の実情に応じて、複数の医療機関機能の選択が可能
※　区域の人口規模については、現在の人口規模に加えて、必要に応じて、2040年の人口等も踏まえながら、どの区域に該当するか等を地域で検討

17

図―４